

HEMOCULTURA POSITIVA PARA *Candida tropicalis*

🧠 ⚠️ HEMOCULTURA POSITIVA PARA *Candida tropicalis* = CANDIDEMIA → EMERGÊNCIA NA UTI

🔬 O QUE ISSO SIGNIFICA NA PRÁTICA?

- *Candida tropicalis* é uma levedura invasiva altamente virulenta
- Muito associada a:
 - Pacientes críticos
 - Neutropenia / onco-hematológicos
 - Uso de ATB amplo espectro
 - CVC prolongado
- Alta mortalidade (~30–60%) se manejo inadequado

👉 Regra de ouro:

📌 Hemocultura positiva para *Candida* = tratar **SEMPRE** (nunca é contaminante)

🚑 CONDOTA IMEDIATA (PRIMEIRA HORA)

1. 🩺 INICIAR ANTIFÚNGICO IMEDIATO

👉 Primeira linha (UTI):

- **Equinocandina (PREFERENCIAL):**
 - Micafungina 100 mg EV 1x/dia
 - OU Anidulafungina 200 mg ataque → 100 mg/dia
 - OU Caspofungina 70 mg ataque → 50 mg/dia

💡 *Candida tropicalis* pode ter resistência ao fluconazol → cuidado

2. 🚫 REMOVER FOCO (CRÍTICO)

- 🔥 **RETIRAR CVC imediatamente**
- Avaliar:
 - SNE / cateter urinário
 - Próteses / dispositivos

3. 🔍 INVESTIGAÇÃO SISTÊMICA (OBRIGATÓRIO)

Checklist:

- 👁 **Fundoscopia** (endoftalmite)
- ❤ **Ecocardiograma** (endocardite fúngica)
- 🧠 Se sintomas → neuroimagem
- ❤️ Avaliar múltiplos focos metastáticos

4. 🌱 REPETIR HEMOCULTURAS

- A cada 48h até negativar

🕒 TEMPO DE TRATAMENTO

👉 Mínimo:

- **14 dias após:**
 - Primeira hemocultura negativa
 - Resolução clínica

DES-ESCALONAMENTO

👉 Se:

- Paciente estável
- Cepa sensível

➡ Pode trocar para:

- Fluconazol 400–800 mg/dia

⚠️ ARMADILHAS CLÁSSICAS (TEMI ALERT 🇵🇹)

- ❌ NÃO retirar o CVC → ↑ mortalidade
- ❌ Usar fluconazol empírico em paciente grave
- ❌ Não fazer fundoscopia
- ❌ Não repetir hemocultura
- ❌ Interromper tratamento antes de negativar cultura

🧠 PEROLAS DE PROVA (TEMI)

- *Candida tropicalis*:
 - Alta associação com neutropenia
 - Maior capacidade de invasão hematogênica
- Equinocandinas = **primeira escolha na UTI**
- Candida em sangue = **sempre patológica**

🧩 RACIOCÍNIO CLÍNICO RÁPIDO (PLANTÃO)

FEBRE + CVC + ATB PROLONGADO
↓
HEMOCULTURA + Candida
↓
RETIRA CVC + INICIA EQUINOCANDINA
↓
SCREENING METASTÁTICO + REPETE CULTURA
↓
NEGATIVOU → 14 DIAS



💊 PRESCRIÇÃO PRONTA (COPIAR E COLAR)

1. Micafungina 100 mg EV 1x/dia
2. Retirada imediata de CVC
3. Coletar hemoculturas seriadas (48/48h)
4. Solicitar fundoscopia
5. Solicitar ecocardiograma transtorácico
6. Avaliar foco infeccioso secundário



🔥 NÍVEL AVANÇADO (UTI HARDCORE)

- Considerar:
 - Clearance lento → pensar em foco profundo

- Persistência > 5 dias → suspeitar endocardite
- BDG (beta-D-glucan) pode ajudar no follow
- Score de risco (Candida score >2,5)



SUGESTÕES DE APROFUNDAMENTO

- Guidelines:
 - [Infectious Diseases Society of America](#)
- Estudos clássicos:
 - Trial comparando equinocandina vs fluconazol
- Temas pra revisar:
 - Candidíase invasiva vs colonização
 - Candida auris (alerta emergente 🚨)
 - Antifúngicos: mecanismo e resistência



POSSO TE ENTREGAR AGORA (se quiser):

- 📄 PRINT 1080x1920 → algoritmo candidemia pronto pra plantão
- 🇧🇷 Tabela antifúngicos (dose + ajuste renal/hepático)
- 🧠 "TOP 20 PEGADINHAS DE INFECÇÃO FÚNGICA NA UTI"
- 🔥 Flashcards estilo prova TEMI
- 📦 PACK INFECÇÃO NA UTI COMPLETO

Só me fala o que quer que eu já monto pra você 🚀

MICAFUNGINA TEM AJUSTE PARA FUNÇÃO RENAL ?



MICAFUNGINA E FUNÇÃO RENAL — RESPOSTA DIRETA DE PLANTÃO

👉 NÃO precisa ajuste para função renal ❌👤



POR QUÊ?

- Metabolismo: hepático (via arilsulfatase e catecol-O-metiltransferase)
- Eliminação: mínima via renal
- Ligação proteica alta (>99%)

👉 Ou seja:

🚫 Clearance renal praticamente irrelevante



NA PRÁTICA (UTI)

Situação	Ajuste de dose
DRC leve/moderada	✗ Não
DRC avançada	✗ Não
Diálise (HD ou DP)	✗ Não
CRRT (hemodífiltração)	✗ Não

- 👉🔥 Dose padrão mantida:
- 100 mg EV 1x/dia (candidemia)

⚠️ ATENÇÃO — O QUE IMPORTA MESMO

🧠 1. Função hepática

- Pode haver ↑ níveis em hepatopatia
- Mas geralmente **não exige ajuste formal**
- Monitorar:
 - TGO/TGP
 - FA / BT

🩺 2. Interações

- Poucas relevantes (vantagem na UTI 👍)
- Não depende de CYP450 significativo

🧠 3. Vantagem na UTI

- 👉 Ideal para:
- Paciente com IRA
 - Instabilidade hemodinâmica
 - Uso de múltiplas drogas

📌 PEROLA DE PROVA (TEMI)

- 👉 Equinocandinas (micafungina, anidulafungina, caspofungina):
- ✗ Não ajustam na insuficiência renal
 - ✅ Primeira escolha em candidemia grave

💥 COMPARAÇÃO RÁPIDA

Droga	Ajuste renal
Micafungina	✗
Anidulafungina	✗
Caspofungina	✗
Fluconazol	✅ (AJUSTAR!)

🧠 RACIOCÍNIO DE OURO (PLANTÃO)

👉 Paciente UTI + IRA + candidemia

➡ Micafungina = escolha perfeita

🚀 SE QUISER APROFUNDAR:

- 📄 PRINT 1080x1920 → "Antifúngicos na UTI (dose + ajuste renal/hepático)"
- 🇮🇹 Tabela completa antifúngicos (incluindo anfotericina B lipossomal)

Só falar que eu monto tudo pra você ⚡

TEMPO DE TRATAMENTO COM MICA FUNGINA

🔥🧠 TEMPO DE TRATAMENTO DA CANDIDEMIA (*Candida tropicalis*) COM MICA FUNGINA

🕒 REGRA DE OURO (TEMI / IDSA)

👉 Baseado nas recomendações da Infectious Diseases Society of America:

✅ MÍNIMO: 14 DIAS APÓS:

- 🌿 Primeira hemocultura negativa
- 🩺 Resolução dos sinais e sintomas clínicos

⚠️ TRADUÇÃO PRÁTICA (PLANTÃO)

👉 NÃO é:

- ❌ 14 dias desde início do antifúngico
- ❌ 14 dias desde a primeira cultura positiva

👉 É:

✅ 14 dias a partir do "clearance" da fungemia

🔄 PASSO A PASSO CLÍNICO

- 📄 Inicia micafungina
- 🔪 Remove CVC
- 🌿 Repete hemocultura (48/48h)
- 📄 Quando negativar → começa contagem
- 🕒 Completa 14 dias

🚑 SITUAÇÕES QUE PROLONGAM TRATAMENTO

👉 Pense em >14 dias se:

- ❤️ Endocardite fúngica
- 👁️ Endoftalmite
- 🧠 Abscessos / foco profundo
- 🩺 Infecção disseminada persistente
- 🌿 Hemoculturas persistentemente positivas

🔄 DES-ESCALONAMENTO (IMPORTANTE)

👉 Se paciente estabiliza e cepa sensível:

➡ Pode trocar para **fluconazol VO/EV**

- Completa os 14 dias totais

🧠 PEROLA DE PROVA (TEMI)

- 📌 Candida em sangue = tratar sempre
- 📌 Tempo = **14 dias após cultura negativa + melhora clínica**
- 📌 Retirada do CVC reduz mortalidade
- 📌 Equinocandina = primeira escolha na UTI

💊 EXEMPLO PRÁTICO

D0: Hemocultura positiva → inicia micafungina
D2: Nova coleta
D4: Cultura negativa
👉 Contagem começa no D4
👉 Tratar até D18



🚀 QUER TURBINAR ISSO AINDA MAIS?

Posso montar pra você:

- 📄 PRINT 1080x1920 → algoritmo candidemia pronto
- 🇧🇷 Tabela completa: antifúngicos + tempo + ajustes
- 🧠 Flashcards TEMI: infecções fúngicas
- 🔥 "Checklist definitivo da candidemia na UTI"
- 📦 PACK INFECÇÃO GRAVE NA UTI

VAZAO DA MICAUFUGINA

💉🧠 VAZÃO DA MICAUFUGINA (COMO INFUNDIR NA PRÁTICA DE UTI)

🕒 REGRA PADRÃO

👉 Infundir em 1 hora (60 minutos)

- ✓ Dose usual: 100 mg EV 1x/dia
- ✓ Diluição típica: 100 mg em 100 mL SF 0,9% ou SG 5%

⚙️ VAZÃO NA BOMBA DE INFUSÃO

👉 Se diluído em 100 mL:

➡ Velocidade = 100 mL/h

🔬 ESQUEMA PRONTO (COPIAR)

Micafungina 100 mg EV diluir em 100 mL SF 0,9%
Infundir em 60 minutos (100 mL/h)
1x ao dia



⚠ CUIDADOS IMPORTANTES

🚫 NÃO FAZER:

- ❌ Infusão rápida (bolus)
- ❌ < 1 hora → risco de reação infusional (histamina-like)

⚠ REAÇÕES INFUSIONAIS

- Rash
- Prurido
- Rubor
- Hipotensão (raro)

👉 Se ocorrer:

➡ Reduzir velocidade

💡 DICAS DE OURO (UTI)

- 📌 Pode usar acesso periférico (menos irritante que anfotericina)
- 🔌 Compatibilidade boa → poucas interações EV
- 🧠 Excelente opção em paciente com IRA

🔥 PEROLA TEMI

👉 Equinocandinas SEMPRE infundir lentamente (≈1h)

👉 Segurança > rapidez

📊 VARIAÇÕES POSSÍVEIS

Volume	Tempo	Vazão
100 mL	1h	100 mL/h
100 mL	2h (se reação)	50 mL/h

🚀 POSSO TE ENTREGAR AGORA:

- 📄 PRINT 1080x1920 → "Drogas EV na UTI (vazão pronta)"
- 📄 Tabela completa de infusão: antibióticos + antifúngicos
- 🧠 Flashcards TEMI: drogas EV
- 🔥 Pack: "Prescrição pronta de UTI"

Só falar que eu já deixo tudo mastigado pra plantão ⚡

📊 Tabela completa antifúngicos (incluindo anfotericina B lipossomal)

Perfeito — isso aqui é **material de bolso nível UTI / TEMI** 🇧🇷🇮🇹🇵🇹
Vou te entregar uma **tabela completa, prática e clínica**, focada no que realmente muda conduta no plantão.

🇧🇷🇮🇹🇵🇹 **TABELA DEFINITIVA – ANTIFÚNGICOS NA UTI**

🧠 **VISÃO RÁPIDA (o que escolher)**

Situação clínica	Droga de escolha
Candidemia grave / UTI	🩸 Equinocandina
Estável + sensível	💊 Fluconazol
Criptococose / histoplasmosse grave	🍄 Anfotericina B
Aspergilose invasiva	🫁 Voriconazol

🩸 **EQUINOCANDINAS (PRIMEIRA LINHA NA UTI)**

Droga	Dose	Ajuste renal	Ajuste hepático	Observações
Micafungina	100 mg/dia	❌	⚠️ leve/moderado	Melhor perfil
Anidulafungina	200 mg ataque → 100 mg/dia	❌	❌	MAIS segura (não hepático)
Caspofungina	70 mg ataque → 50 mg/dia	❌	⚠️ (reduzir)	Interações

🧠 **Perola:** melhor escolha em **paciente crítico + IRA**

💊 **AZÓIS**

💠 **Fluconazol**

Item	Dados
Dose	400–800 mg/dia
Ajuste renal	✅ (OBRIGATÓRIO)
Ajuste hepático	⚠️
Uso	Candidemia estável / step-down

👉 **Evitar empírico em UTI grave**

💠 **Voriconazol**

Item	Dados
Dose	6 mg/kg 12/12h (ataque) → 4 mg/kg
Ajuste renal	❌ (EV tem ciclodextrina ⚠️)
Ajuste hepático	✅
Uso	Aspergilose invasiva



- Neurotoxicidade
- Fotossensibilidade
- MUITAS interações

💠 Itraconazol

- Uso mais ambulatorial
- Absorção errática !

💣 ANFOTERICINA B

🔥 Convencional (DESOXICOLATO)

Item	Dados
Dose	0,7–1 mg/kg/dia
Nefrotoxicidade	🚑 ALTA
Uso	Quase abandonada em UTI

🧠 Anfotericina B Lipossomal (PREFERIDA)

Item	Dados
Dose	3–5 mg/kg/dia
Ajuste renal	❌
Ajuste hepático	❌
Toxicidade renal	📉 menor

⚠️ EFEITOS ADVERSOS IMPORTANTES (anfotericina)

- 💧 Hipocalemia
- 💧 Hipomagnesemia
- 🧠 Nefrotoxicidade
- 💉 Reação infusional

👉 Sempre monitorar:

- K
- Mg
- Creatinina

 COMPARAÇÃO RÁPIDA (OURO)

Classe	Rim	Fígado	Melhor uso
Equinocandina	👍	👍	UTI / candidemia
Fluconazol	⚠️	⚠️	step-down
Voriconazol	👍	⚠️	aspergilose
Anfotericina B	🚫	👍	infecção grave

 ALGORITMO RÁPIDO (PLANTÃO)

CANDIDEMIA

↓

GRAVE / UTI ?

→ SIM → EQUINOCANDINA

→ NÃO → FLUCONAZOL

↓

ESTABILIZOU + SENSÍVEL

→ STEP DOWN FLUCONAZOL

↓

FOCO PROFUNDO ?

→ PROLONGAR TRATAMENTO



 PEGADINHAS CLÁSSICAS (TEMI)

- ❌ Fluconazol sem ajuste renal
- ❌ Não retirar CVC na candidemia
- ❌ Usar anfotericina convencional em UTI
- ❌ Esquecer K e Mg na anfotericina
- ❌ Voriconazol EV em DRC avançada (ciclodextrina!)

 NÍVEL AVANÇADO (DIFERENCIAL)

- Equinocandinas → fungicidas contra Candida
- Azóis → fungistáticos
- Anfotericina → mais potente (membrana fúngica)

 REFERÊNCIA CLÁSSICA

- Infectious Diseases Society of America
- Trials equinocandina vs fluconazol (mudaram conduta global)

 POSSO TE ENTREGAR AGORA (HIGH PERFORMANCE)

 PACK UTI ANTIFÚNGICOS:

- 📄 Print 1080x1920 (wallpaper pronto)
- 🇧🇷 Tabela com dose por peso (40–120 kg)
- 🧴 Diluição + vazão de TODOS antifúngicos
- 🧠 Flashcards TEMI
- 🔥 “Top 20 erros fatais com antifúngicos na UTI”

Se quiser, posso montar também:

- 👉 "GUIA VISUAL DEFINITIVO DA CANDIDEMIA (nível especialista)"
- 👉 "ANTIFÚNGICOS + INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS NA UTI"
- 👉 "MAPA MENTAL: INFECÇÕES FÚNGICAS INVASIVAS"

Só me dizer 🚀

GUIA VISUAL DEFINITIVO DA CANDIDEMIA (nível especialista)

Perfeito — isso aqui é **material de alto nível para decisão rápida + prova TEMI + beira-leito** 🔥🧠
Vou te entregar um **GUIA VISUAL estruturado (estilo algoritmo mental + checklist)** — exatamente o que você precisa no plantão.

🦠🔥 **GUIA VISUAL DEFINITIVO DA CANDIDEMIA (NÍVEL ESPECIALISTA)**

🚩 **1. SUSPEITA CLÍNICA (QUANDO PENSAR)**

PACIENTE UTI + FEBRE PERSISTENTE SEM FOCO
+ ATB DE AMPLO ESPECTRO
+ CVC
+ NPT / SNE / CIRURGIA ABDOMINAL
↓
PENSAR EM CANDIDEMIA



- 🧠 **Score útil (Candida Score):**
- Cirurgia + NPT + colonização + sepse grave
👉 ≥ 2,5 → alto risco

🩺 **2. DIAGNÓSTICO**

- 🩸 Hemocultura positiva → **CONFIRMA**
 - 🕒 Pode demorar → não esperar em paciente grave
- 📌 **Biomarcadores:**
- Beta-D-glucan (BDG) → suporte diagnóstico

⚠️ **REGRA DE OURO**

- 👉 **Candida em sangue = SEMPRE tratar (NUNCA contaminante)**

3. TRATAMENTO INICIAL (PRIMEIRA HORA)

ESCOLHA EMPÍRICA (UTI)

Equinocandina

- Micafungina 100 mg/dia
- OU Anidulafungina
- OU Caspofungina

4. CONTROLE DE FOCO (O MAIS IMPORTANTE!)

CANDIDEMIA

↓

RETIRAR CVC IMEDIATAMENTE

↓

AVALIAR:

- SNE
- SVD
- PRÓTESES



 Não retirar CVC = ↑ mortalidade

5. SCREENING OBRIGATÓRIO (FOCOS METASTÁTICOS)

Órgão	Exame
 Olho	Fundoscopia
 Coração	Ecocardiograma
 SNC	TC/RM se sintomas
 Pulmão	TC se suspeita

6. FOLLOW-UP

- Hemocultura 48/48h
- Até negativar

7. TEMPO DE TRATAMENTO

INÍCIO DA CONTAGEM:

↓

PRIMEIRA CULTURA NEGATIVA

+

MELHORA CLÍNICA

↓

TRATAR 14 DIAS



8. DES-ESCALONAMENTO

Critérios:

- Estável
- Cultura sensível
- Sem foco profundo

 Trocar para fluconazol

🚨 9. QUANDO PROLONGAR TRATAMENTO

- Endocardite ❤️
- Endoftalmite 👁️
- Abscesso 🧠
- Fungemia persistente

🧠 10. DIFERENÇAS IMPORTANTES (ESPÉCIES)

Espécie	Observação
Candida albicans	mais comum
Candida glabrata	resistente fluconazol
Candida tropicalis	MAIS invasiva 🔥
Candida parapsilosis	biofilme (CVC)

⚠️ 11. ERROS FATAIS (TEMI)

- ❌ Não retirar CVC
- ❌ Usar fluconazol empírico em grave
- ❌ Não fazer fundoscopia
- ❌ Não repetir hemocultura
- ❌ Tratar <14 dias

🧠 12. RACIOCÍNIO DE OURO (PLANTÃO)

HEMOCULTURA + Candida
↓
EQUINOCANDINA + RETIRA CVC
↓
SCREENING METASTÁTICO
↓
REPETE CULTURA
↓
NEGATIVO → 14 DIAS



💊 13. PRESCRIÇÃO AUTOMÁTICA

Micafungina 100 mg EV 1x/dia
Retirada imediata de CVC
Hemoculturas seriadas 48/48h
Fundoscopia
Ecocardiograma
Monitorar função hepática



🧠 NÍVEL HARDCORE (DIFERENCIAL DE ESPECIALISTA)

- Persistência > 3–5 dias → pensar:
 - Endocardite
 - Foco profundo

- *Candida tropicalis* → mais agressiva
- BDG útil para acompanhamento
- Clearance lento = pior prognóstico



BASE CIENTÍFICA

- Infectious Diseases Society of America
- Trials equinocandinas (mudaram padrão mundial)



QUER TURBINAR ISSO AINDA MAIS?

Posso montar pra você:



MATERIAL VISUAL PRONTO

- Wallpaper 1080x1920 (fluxograma completo)
- Tabela rápida de bolso



ESTUDO TEMI

- Flashcards de candidemia
- "Top 30 questões comentadas"



PRÁTICA UTI

- Tabela: antifúngicos + dose + diluição + vazão
- Algoritmo sepse + fungemia integrado

Se quiser, posso evoluir isso para:



"INFECÇÕES FÚNGICAS NA UTI – PACK COMPLETO (nível especialista)"



"DIFERENCIAÇÃO RÁPIDA: CANDIDA vs ASPERGILLUS vs CRYPTOCOCCUS"



"MAPA MENTAL VISUAL (1 página)"

Só me falar ⚡🔥

DIFERENCIAÇÃO RÁPIDA: CANDIDA vs ASPERGILLUS vs
CRYPTOCOCCUS

Perfeito — isso aqui é ouro de prova + decisão imediata na UTI 🔥🧠

Vou te entregar um **comparativo direto, visual e clínico**, pra bater o olho e decidir rápido.



DIFERENCIAÇÃO RÁPIDA — *Candida* vs *Aspergillus* vs *Cryptococcus*

 VISÃO ULTRA-RÁPIDA (PLANTÃO)

SANGUE → pensa em Candida
PULMÃO (nódulo/halo) → Aspergillus
SNC (meningite) → Cryptococcus



 TABELA DEFINITIVA (DECISÃO RÁPIDA)

Característica	 Candida	 Aspergillus	 Cryptococcus
Tipo	Levedura	Fungo filamentoso	Levedura encapsulada
Principal local	 Sangue	 Pulmão	 SNC
Doença típica	Candidemia	Aspergilose invasiva	Meningite
Paciente típico	UTI, CVC, ATB	Neutropênico	HIV/imunossuprimido
Porta de entrada	Cateter	Inalação	Inalação
Hemocultura	 comum	 raro	 raro
Imagem	inespecífica	 Halo sign	hidrocefalia
Teste chave	Hemocultura	Galactomanana	Antígeno criptocócico
Tratamento inicial	Equinocandina	Voriconazol	Anfotericina + flucitosina

 CANDIDA (UTI PURA)

 Pistas clínicas:

- CVC 
- ATB prolongado 
- NPT 
- Sepses sem foco

 Diagnóstico:

- Hemocultura positiva

 Tratamento:

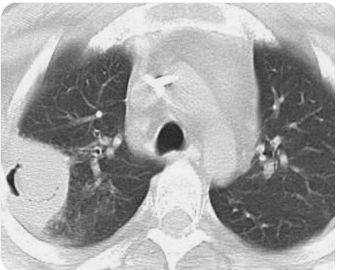
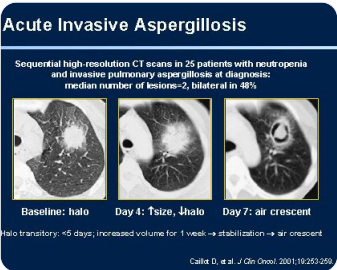
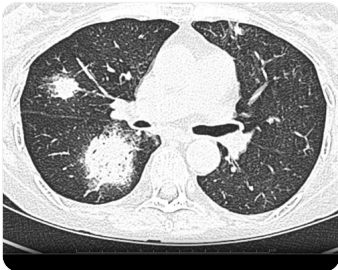
-  Equinocandina

 Frase de prova:

 “Candida no sangue = tratar sempre”

 ASPERGILLUS (PULMÃO INVASIVO)

 Imagem típica (ESSENCIAL)



Pistas:

- Neutropenia
- Corticoide
- Transplante

TC:

- Sinal do halo (clássico 🔥)

Diagnóstico:

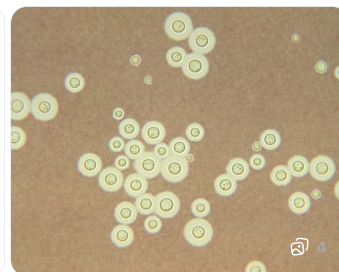
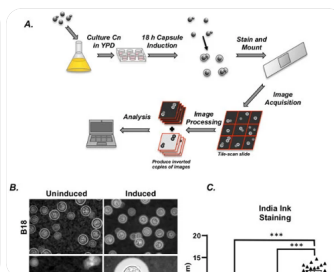
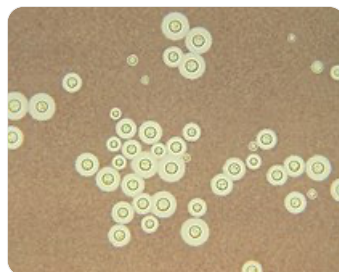
- Galactomanana

Tratamento:

- 🍄 Voriconazol

Frase de prova:

👉 "Nódulo pulmonar + halo = aspergilose até prova contrária"

CRYPTOCOCCUS (MENINGITE SUBAGUDA)**Estrutura encapsulada (clássico)****Pistas:**

- HIV avançado
- Cefaleia subaguda
- Hipertensão intracraniana

Diagnóstico:

- Antígeno criptocócico (CrAg)

Tratamento:

- 🌐 Anfotericina + flucitosina

Frase de prova:

👉 "Levedura encapsulada + SNC = cryptococcus"

ERROS CLÁSSICOS (TEMI)

- ❌ Tratar candidemia com fluconazol inicial em paciente grave
- ❌ Não pensar em aspergilose no neutropênico
- ❌ Não medir pressão de abertura no líquido (crypto!)
- ❌ Não retirar CVC na candidemia

MAPA MENTAL FINAL

CANDIDA → sangue → equinocandina
 ASPERGILLUS → pulmão → voriconazol
 CRYPTOCOCCUS → SNC → anfotericina + flucitosina



POSSO TE ENTREGAR AGORA:

VISUAL PRONTO

- Wallpaper 1080x1920 (comparativo lado a lado)
- Tabela ultra resumida pra lockscreen

ESTUDO TEMI

- Flashcards (30 perguntas clássicas)
- Casos clínicos simulados

UTI HARDCORE

- Algoritmo: febre persistente no crítico
- Tabela: antifúngicos + escolha por cenário

Se quiser, posso montar agora:

👉 "ALGORITMO: FEBRE SEM FOCO NA UTI (incluindo fungos)"

👉 "TOP 50 PEGADINHAS DE INFECÇÃO NA UTI"

👉 "PACK COMPLETO INFECÇÕES OPORTUNISTAS"

Só me dizer ⚡🧠

PACK COMPLETO INFECÇÕES OPORTUNISTAS

Perfeito. Isso aqui vai virar seu "arsenal mental" de plantão + prova TEMI 🔥🧠

Organizei em formato **ultra prático, decisional e memorizável** — pra você usar sob pressão.

🔥 PACK COMPLETO — INFECÇÕES OPORTUNISTAS (UTI / TEMI)

1. MAPA MENTAL CENTRAL (OURO)

IMUNOSSUPRIMIDO + FEBRE

↓

LOCAL PRINCIPAL?

→ SNC → Cryptococcus / Toxoplasma

→ Pulmão → Pneumocystis / Aspergillus

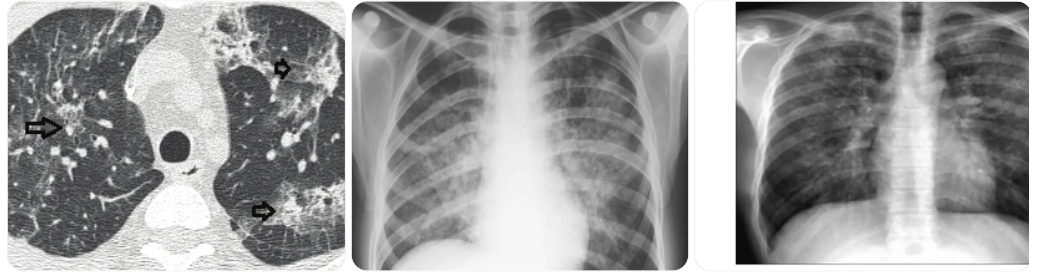
→ Sangue → Candida

→ Sistêmico → CMV / Histoplasma / TB



2. PULMÃO (MAIS COBRADO)

 Pneumocystis jirovecii (PJP)



Pistas:

- HIV CD4 < 200
- Dispneia progressiva
- Hipoxemia desproporcional

Diagnóstico:

- TC: vidro fosco difuso
- LDH ↑
- PCR/BAL

Tratamento:

- SMX-TMP alta dose
- corticoide se $\text{PaO}_2 < 70$

Aspergilose invasiva

- ➡ Neutropênico + halo sign
- ➡ Tratamento: Voriconazol

3. SNC

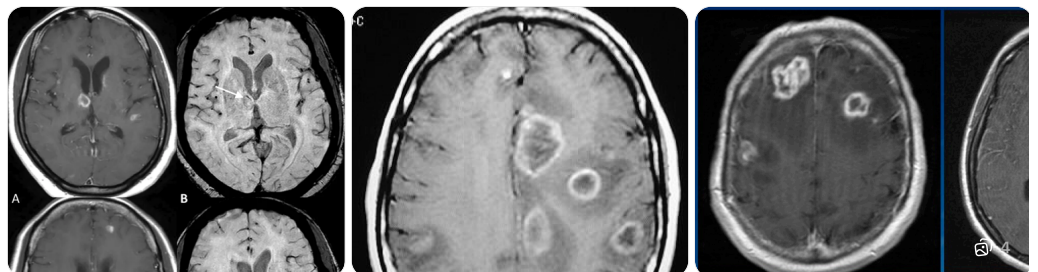
Cryptococcus

- ➡ HIV avançado
- ➡ Cefaleia subaguda

Tratamento:

- Anfotericina B + flucitosina
- Controle de pressão intracraniana 🔥

Toxoplasmose cerebral



Pistas:

- HIV CD4 < 100
- Lesões em anel

Tratamento:

- Sulfadiazina + pirimetamina + ácido folínico

🔴 4. CORRENTE SANGUÍNEA

🦠 Candidemia

👉 UTI + CVC + ATB

🩺 Tratamento:

- Equinocandina
- Retirar CVC 🔥

🌐 5. INFECÇÕES SISTÊMICAS

🦠 Histoplasmose

- Febre + hepatoesplenomegalia
- Imunossuprimido

🩺 Tratamento:

- Anfotericina → itraconazol

🦠 CMV

- Retinite 👁
- Pneumonite

🩺 Tratamento:

- Ganciclovir

🦠 Tuberculose disseminada

- Febre + sudorese
- Pancitopenia

⚠️ 6. CHECKLIST DE PLANTÃO (OURO)

IMUNOSSUPRIMIDO GRAVE

↓

1. LOCALIZAR FOCO
2. COLETAR EXAMES
3. INICIAR TERAPIA EMPÍRICA
4. COBRIR FUNGOS SE NECESSÁRIO
5. AVALIAR PROFILAXIA



💊 7. TABELA RÁPIDA (DECISÃO)

Doença	Droga
Candidemia	Equinocandina
PJP	SMX-TMP
Aspergillus	Voriconazol
Cryptococcus	Anfotericina + flucitosina
Toxoplasmose	Sulfadiazina + pirimetamina
CMV	Ganciclovir

8. PEGADINHAS TEMI

-  Não iniciar corticoide na PJP grave
-  Não retirar CVC na candidemia
-  Confundir toxoplasmose com linfoma SNC
-  Não tratar hipertensão intracraniana no crypto
-  Esquecer CMV em imunossuprimido

9. DIFERENCIAL AVANÇADO (CLÍNICO)

Situação	Pensar
Vidro fosco difuso	PJP
Nódulo + halo	Aspergillus
Lesão em anel SNC	Toxo
Meningite subaguda	Crypto
Sepse sem foco	Candida

BASE

- [Infectious Diseases Society of America](#)
- Guidelines HIV / UTI

AGORA VAMOS TURBINAR (SE QUISER)

Posso montar pra você:

VISUAL

- Wallpaper 1080x1920 (tudo em 1 tela)
- Mapa mental gráfico

ESTUDO

- Flashcards (50 questões TEMI)
- Casos clínicos comentados

PRÁTICA

- Prescrição automática de todas as doenças

- Tabela completa com doses por peso

🔥 NÍVEL HARDCORE

- "FEBRE NO IMUNOSSUPRIMIDO — algoritmo definitivo"
- "INFECÇÕES OPORTUNISTAS + VM + CHOQUE (integração UTI)"

Se quiser, posso montar agora:

👉 **VERSÃO PRINT 1080x1920 (PRONTA PRA CELULAR)**

👉 **CHECKLIST DE PLANTÃO EM 1 PÁGINA**

👉 **ALGORITMO COMPLETO DO IMUNOSSUPRIMIDO GRAVE**

Só me dizer ⚡🧠

ALGORITMO COMPLETO DO IMUNOSSUPRIMIDO GRAVE

Perfeito — isso aqui é **protocolo de guerra na UTI** 🔥🧠

Vou te entregar um **ALGORITMO COMPLETO, sequencial e acionável**, pensado pra decisão rápida sob pressão + prova TEMI.

🧠🔥 ALGORITMO COMPLETO — PACIENTE IMUNOSSUPRIMIDO GRAVE (UTI)

📌 1. RECONHECIMENTO IMEDIATO

IMUNOSSUPRIMIDO + FEBRE / INSTABILIDADE
↓
ASSUMIR INFECÇÃO GRAVE ATÉ PROVA CONTRÁRIA



🎯 Quem é alto risco?

- HIV CD4 < 200
- Neutropenia (<500)
- Corticoide / imunobiológico
- Transplante
- Onco-hematológico

⚡ 2. PRIMEIRA HORA (SEPSIS PACKAGE ADAPTADO)

1. CULTURAS (ANTES DO ATB se possível)
2. ANTIBIÓTICO DE AMPLO ESPECTRO IMEDIATO
3. LACTATO + GASO + LABS
4. FLUIDO + VASOATIVO SE NECESSÁRIO



💊 ATB empírico:

- Piperacilina-tazobactam OU cefepime OU meropenem
- • vancomicina se risco MRSA

3. LOCALIZAÇÃO DO FOCO (DECISÃO CRÍTICA)

↓ FOCO PRINCIPAL ↓

-  Pulmão
-  SNC
-  Sangue
-  Sistêmico



4. SE FOCO PULMONAR

VIDRO FOSCO DIFUSO → PJP
NÓDULO + HALO → ASPERGILLUS
CONSOLIDAÇÃO → BACTÉRIA



Conduta:

- Suspeita PJP → SMX-TMP + corticoide
- Suspeita Aspergillus → Voriconazol

5. SE FOCO SNC

MENINGITE SUBAGUDA → CRYPTOCOCCUS
LESÃO EM ANEL → TOXOPLASMOSE



Conduta:

- Crypto → Anfotericina + flucitosina
- Toxo → Sulfadiazina + pirimetamina

6. SE SEPSE SEM FOCO (UTI CLÁSSICO)

CVC + ATB PROLONGADO
↓
PENSAR EM CANDIDEMIA



Conduta:

- Equinocandina
- Retirar CVC 🔥

7. SE QUADRO SISTÊMICO

FEBRE + HEPATOESPLENOMEGALIA → HISTOPLASMOSE
RETINITE / PNEUMONITE → CMV



8. EXAMES ESSENCIAIS (NÃO PERDER)

-  Hemoculturas seriadas
-  TC de tórax
-  TC/RM se SNC
-  Fundoscopia
-  BDG / galactomanana / CrAg

⚠️ 9. QUANDO INICIAR ANTIFÚNGICO EMPÍRICO

👉 Iniciar se:

- Neutropenia prolongada + febre persistente
- Instabilidade sem foco
- Alto risco (Candida score alto)

🕒 10. REAVALIAÇÃO 48–72h

MELHOROU?

- SIM → manter / ajustar
- NÃO → ampliar cobertura (fungo / vírus)

🚑 11. RED FLAGS (MUDAM CONDUTA)

- Choque refratário
- Lactato alto persistente
- Cultura positiva fúngica
- Neutropenia profunda

🧠 12. RACIOCÍNIO FINAL (OURO)

IMUNOSSUPRIMIDO GRAVE
↓
ATB IMEDIATO
↓
LOCALIZA FOCO
↓
COBRE FUNGO SE NECESSÁRIO
↓
REAVALIA 48h

💊 13. PRESCRIÇÃO BASE (PRONTO)

1. Piperacilina-tazobactam OU meropenem
2. Vancomicina (se indicado)
3. Considerar:
 - Micafungina (alto risco fungo)
 - SMX-TMP (se PJP)
4. Coletar culturas
5. TC tórax

⚠️ 14. ERROS GRAVES (TEMI)

- ❌ Atrasar antibiótico
- ❌ Não pensar em fungo
- ❌ Não investigar SNC
- ❌ Não retirar CVC
- ❌ Não reavaliar em 48h

🧠 NÍVEL HARDCORE (ESPECIALISTA)

- Febre persistente = pensar em fungo

- PJP → hipoxemia desproporcional
- Aspergillus → angioinvasão
- Candida → biofilme (cateter)
- Crypto → hipertensão intracraniana mata

BASE

- [Infectious Diseases Society of America](#)

POSSO EVOLUIR ISSO PRA VOCÊ AGORA:

VISUAL

- Wallpaper 1080x1920 (fluxograma completo)
- Checklist de bolso (1 página)

ESTUDO

- Flashcards TEMI
- Casos clínicos simulados

PRÁTICA

- Doses por peso (40–120 kg)
- Integração com VM + choque

ELITE

- “SEPSE NO IMUNOSSUPRIMIDO — PROTOCOLO COMPLETO”
- “INFECÇÃO + INSTABILIDADE HEMODINÂMICA”

Se quiser, te entrego agora:

-  **VERSÃO PRINT PRONTA PRA CELULAR (ESTILO MAPA VISUAL)**
-  **CHECKLIST ULTRA-RESUMIDO PRA PLANTÃO (10 LINHAS)**
-  **SIMULADO TEMI (CASOS REAIS)**